

ATLS · ABCDE do trauma

No politrauma, trate primeiro o que mata primeiro. A ordem ABCDE é rígida na prova: via aérea com proteção cervical !' respiração !' circulação !' neurológico !' exposição.

Âncoras por letra

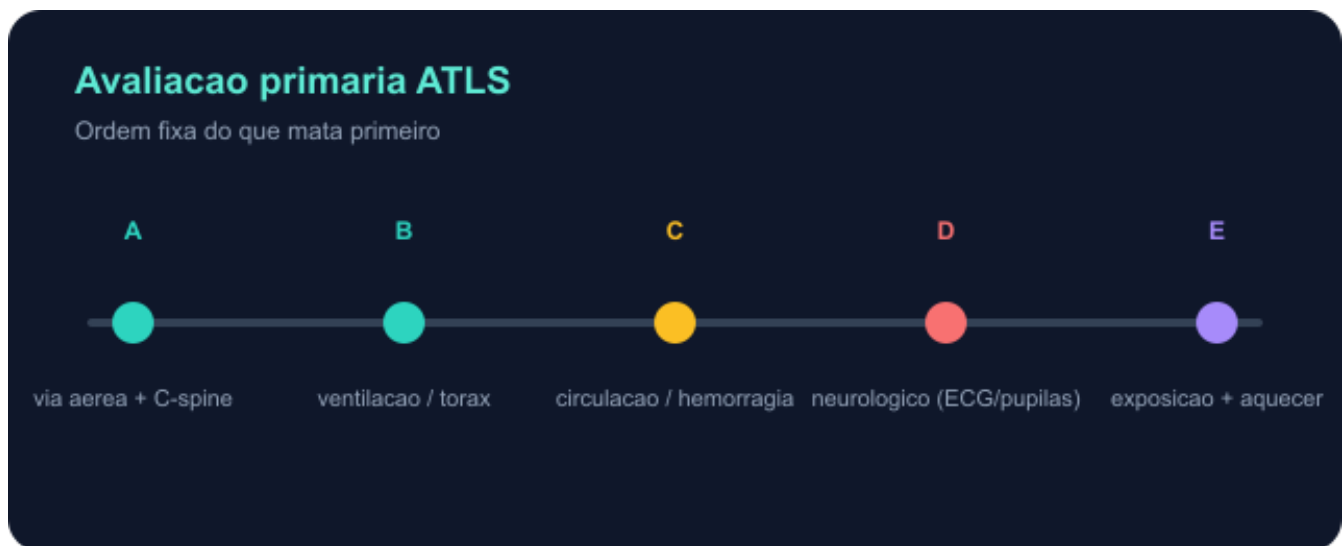
- A: permeabilidade, corpo estranho, IOT se GCS "d 8 ou ameaça iminente; colar cervical
- B: inspeção, SpO₂, PNTs hipertensivo/aberto, tórax instável — descomprimir antes de RX se tensão
- C: controle de sangramento externo, 2 acessos calibrosos, cristalóide/sangue, pelve/FAST
- D: GCS, pupilas, déficits focais
- E: despir, procurar lesões ocultas, prevenir hipotermia

XABCDE

Dica - XABCDE

Em alguns protocolos, o 'X' (hemorragia exsanguinante externa) vem antes do A — garrote/compressão imediata.

Memorize a sequência; só avance após estabilizar a ameaça atual.



Ameaças clássicas de B e C

Problema | Conduta imediata

PNT hipertensivo | Descompressão com agulha / toracostomia

PNT aberto | Curativo de 3 pontas + dreno

Tamponamento | Volume prudente + via para pericardiocentese/janela

Choque hemorrágico | Controle da fonte + sangue / protocolo de massa

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não leve o instável para TC 'para mapear'. Sangramento interno com choque !' sala / controle de dano, não imagem demorada.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

ATLS: exame primário ABCDE salva vida antes do diagnóstico etiológico completo. Memorize a ordem e as ameaças de cada letra.

Trate ameaças na ordem em que aparecem; só avance quando a letra atual estiver controlada.

ABCDE - exame primario

ATLS - ordem obrigatoria

- 1 A - Airway + protecao cervical
- 2 B - Breathing / ventilacao
- 3 C - Circulation + controle hemorragia
- 4 D - Disability (neuro / glicemia)
- 5 E - Exposure + ambiente (hipotermia)

Reavaliar ABCDE apos cada intervencao

Ameças clássicas por letra

Letra | Ameça / conduta-chave

- A | Obstrução, trauma facial; C-spine; via definitiva se necessário
- B | PNT hipertensivo, aberto, hemotórax massivo, tórax instável
- C | Choque hemorrágico; compressão; acesso; sangue; FAST/radiografia
- D | ECG/pupilas; Glasgow; glicemia; lateralizar se lateralização
- E | Expor totalmente; prevenir hipotermia; log-roll com proteção

Adjuncts do primário

Dica - Adjuncts do primário

Monitorização, oximetria, EtCO₂, se intubado, gasometria, Rx cervical/tórax/pelve, FAST, sonda gástrica/vesical quando indicados — sem atrasar tratamento salva-vidas.

Exame secundário (ideia)

- História AMPLE (alergias, meds, passado, last meal, eventos)
- Cabeça-a-pés após estabilização do primário
- Reavaliar continuamente — deterioração = voltar ao ABCDE

Prova

Atencao - Prova

Pneumotórax hipertensivo é diagnóstico clínico — não atrase descompressão para 'confirmar no Rx' no instável.